

7 - 01- LE CANCER DU LARYNX - Pr. ROCHDI

Bonjour tout le monde. On va traiter aujourd'hui le cancer du larynx, qui est un cancer qui est fréquent, puisqu'il constitue 25% des cancers de la sphère ORL. Il est en rapport avec l'exposition au tabac, c'est-à-dire l'intoxication tabagique.

Le diagnostic radioclinique est basé sur la nasofibroscopie, la laryngoscopie directe avec le biopsie et le scanner cervical. La prise en charge est multidisciplinaire. Ça concerne le médecin ORL, le radiologue, l'oncologue, l'anatome pathologiste, ainsi que le médecin traitant qui participe au diagnostic ainsi qu'au suivi.

Le traitement englobe la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie avec des indications en fonction du stade et de la localisation. Le pronostic reste meilleur en cas de diagnostic fréquent. Sur le plan épidémiologique, il constitue 5% de l'ensemble des cancers chez l'homme, 25% des cancers des voies aérodynamiques supérieures.

L'incidence au Maroc est estimée à 5,6% chez l'homme et il est responsable de 3600 décès par an aux ISA. On se concerne de l'âge. L'âge moyen est de 59 ans à peu près 60 ans et ça peut aller de 45 à 70 ans avec une nette prédominance masculine malgré une certaine augmentation récemment concernant la femme. On note de plus en plus de tabagisme chez les femmes, surtout en Occident.

Concernant les facteurs de risque, en premier c'est le tabac qui multiplie le risque 6 à 10 fois. L'alcool aussi, c'est un cofacteur. Ce n'est pas un facteur direct, c'est un cofacteur.

L'alcool est incriminé beaucoup plus avec le tabac dans les cancers de l'euparynx et de l'hépoparynx. Les infections virales, surtout au human papilloma virus, le HPV, le serotype 16, qui est responsable de la papillomatose laryngée. Cette papillomatose laryngée peut entraîner une dégénérescence maligne avec transformation en un cancer, mais qui reste quand même rare.

Ce risque ne dépasse pas 3%. D'autres facteurs de risque, c'est les risques professionnels en rapport avec l'inhalation de poussière d'amiante, de bois, de ciment, de nickel, de sulfurotoxiques et parfois d'évaporés de diesel. Le reflux gastro-oesophagien est aussi incriminé, puisqu'il peut être responsable de l'arrondissement chronique.

Tous ces facteurs vont entraîner l'apparition de ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, des caratomes, des mycoplasmes, avec, à la longue, une dégénérescence maligne. Avant de voir l'anatomopathologie ainsi que le reste des paragraphes, on va faire un rappel anatomique en premier. Le larynx est un organe qui fait partie des voies aériennes supérieures, qui est constitué d'un squelette cartilagineux, qui est relié par des ligaments et des muscles, et le tout est recouvert par une muqueuse, qu'on appelle la muqueuse de larynx.

Alors, le squelette est constitué par le cricoidé, ici en bas, qui relie le larynx à la trachée, le

cartilage thyroïde qui ferme le larynx en avant, et entre le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde il y a la membrane cricothyroïdienne. Entre le cartilage thyroïde et l'occyphoïde, il y a la membrane thyroïdienne qui ferme la loge thyro-épiglottique en avant. Sur le même schéma, si on le regarde en arrière, on va voir le cartilage cricoïde qui s'articule au niveau de son bord supérieur avec les deux cartilages aréthroïdes pour former l'articulation crico-aréthroïdienne qui a une importance physiologique capitale.

Le cartilage épiglottique avec sa forme triangulaire est filé en bas et là en haut. Et puis il y a ici les ligaments arri-épiglottiques qui sous-tendent la muqueuse. Sur un autre schéma avec un larynx en coupe frontale, on voit le larynx qui est tapissé par la muqueuse et on reconnaît trois étages avec l'étage susglottique, l'étage soglottique et l'étage glottique constitué par les cordes vocales qui s'insèrent sur les apophyses vocales du cartilage aréthroïde.

Juste au-dessus du plan glottique, on a le plan susglottique qui est constitué par les ventricules de l'organe. C'est des pressions qu'on voit ici. Au-dessus des ventricules, il y a les bandes ventriculaires avec le vestibule laryngé.

Le bord supérieur du larynx on l'appelle la margène laryngée qui fait partie de l'étage susglottique. L'étage soglottique est sous le plan glottique et se continue avec la trachée. Là, c'est une coupe frontale, un schéma qui montre une coupe frontale du larynx où on reconnaît les trois étages.

Donc, vous avez ici en haut, ici au centre, vous avez le plan glottique avec la muqueuse qui recouvre les cordes vocales avec le muscle thyro-aréthroïde ici. Juste au-dessus, il y a les ventricules avec les bandes ventriculaires ainsi que le vestibule laryngé. Au-dessus du plan glottique, on a le plan soglottique.

Même schéma qui montre la même chose avec les rapports latéraux du larynx qui sont les sinus périplants. Alors là, c'est une vue supérieure du larynx et qu'il faudra retenir parce que lorsqu'on fait un examen au miroir laryngé, voilà l'image en général qu'on a. Là, c'est l'épiglotte avec les deux rubans blanchâtres qui sont les cordes vocales. Latéralement, on a les bandes ventriculaires.

En arrière, c'est la commissure postérieure. Là, la commissure antérieure. Là, la commissure postérieure.

Et là, les cartilages aréthroïdes, les cartilages corniculés. Et plus en arrière, on a la bouche de lésopage avec les deux sinus périplants. Ça, c'est un autre schéma dans le plan sagittal qui montre très bien les trois étages du larynx avec les cordes vocales à ce niveau-là.

Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'arrière. Le haut.

Le bas. Les cordes vocales à ce niveau-là. Juste au-dessus, c'est les ventricules de Morgagnie,

bandes ventriculaires, ainsi que les vestibules laryngées avec l'épiglotte.

L'espace graisseux qu'on voit ici, c'est l'espace pré-épiglottique ou bien l'espace iotiro-épiglottique qui est plein de graisse. Et l'étage subglottique se continue avec la trachée en bas. Remarquez que le larynx, c'est un organe qui est palpable en avant puisqu'il est directement sous les plans de recouvrement.

Ce sont la peau, tissus subcutané, les aponévres syndicales superficielles et moyennes, ainsi que les muscles sous-évidents. Alors l'innervation du larynx est faite par deux nerfs. D'abord le nerf récurrent, deux nerfs récurrents, un de chaque côté, qui va innerver les muscles intrinsèques du larynx.

Ces muscles intrinsèques sont responsables de l'abduction et de l'adduction des cordes vocales. Le nerf laryngé supérieur, lui, est responsable de la sensibilité de la muqueuse laryngée, donc le réflexe de l'atome, pour assurer la protection des voies olympiennes. Et il est responsable de l'innervation des muscles cricothyroïdiens.

Les muscles cricothyroïdiens sont responsables de la tension des cordes vocales. La vascularisation est assurée par les branches des artères thyroïdiennes supérieures et inférieures. Alors ici on voit les rapports antérieurs du larynx avec la glande thyroïde, avec l'isthme et les deux lobes latéralement, l'axe gígulocarotidien latéralement, et sur une vue postérieure, on voit le rapport avec en haut la base des langues et l'épaule pharynx avec latéralement les deux sinus périmorphes, la bouche de l'oséophage en arrière, ainsi que le reste de l'épaule pharynx.

Alors le drainage lymphatique du larynx est très important à connaître et à savoir, puisqu'il présente des particularités qui ont un impact dans les indications thérapeutiques. Première chose à retenir, c'est qu'au niveau du plan glottique et strictement au niveau des cordes vocales, il n'y a pas de drainage lymphatique. C'est les zones que vous voyez ici en blanc.

Sur le plan glottique des cordes vocales, il n'y a pas de drainage lymphatique. Pour le reste, l'étage subglottique se draine vers les ganglions gígulocarotidiens supérieurs, moyens et inférieurs. L'étage se fait de façon bilatérale et croisée.

L'étage subglottique se draine lui aussi au niveau des ganglions gígulocarotidiens latéraux, en plus d'un drainage supplémentaire pour l'étage subglottique. C'est ce qu'on appelle vers les ganglions prélarangés, prétrachios et latéraux trachios. C'est ce qu'on appelle la chaîne récurrentielle.

Ça, ça s'appelle le compartiment central. Alors ça aussi, ça va avoir une répercussion dans la prise en charge thérapeutique. Alors ces groupes ganglionnaires au niveau cervical, on les sépare en plusieurs groupes.

Pour le groupe 1, c'est le sous-mentosomaxillaire. La chaîne gígulocarotidienne est divisée en

trois groupes. Le groupe 2, c'est le supérieur.

Le 3, c'est le moyen. Le 4, c'est l'inférieur. Le groupe 5, c'est le groupe subsclaviculaire.

C'est le groupe 5. Et puis le groupe 6, c'est le compartiment central. Pourquoi on insiste sur le drainage lymphatique ? Parce que ça va être une voie d'extension du cancer du larynx vers les ganglions. C'est-à-dire qu'on aura des métastases ganglionnaires et il faudra assurer, en plus du traitement de la tumeur au niveau du larynx, un traitement au niveau des ganglions.

Alors, sur le plan anatomopathologique, macroscopiquement, le cancer du larynx se présente soit sous forme bourgeonnante, soit sous forme de tumeur ulcérée ou bien infiltrante. Parfois, on peut avoir une association, c'est-à-dire une tumeur ulcéro-infiltrante ou bien une tumeur ulcérée et bourgeonnante. Sur le plan microscopique, le type histologique le plus fréquent, c'est le carcinome épidermoïde avec parfois certains variants et constitue 95% des cancers qui touchent le larynx et qui est en rapport surtout avec l'exposition ou bien l'intoxication alcoolo-tabagique.

On peut avoir des tumeurs rares, comme le chondrosarcome, les tumeurs des glandes salivaires, les mélanomes, etc., des lymphomes, des adénocarcinomes, mais ça reste très rare, voire exceptionnel. Alors, ce cancer va être responsable d'une invasion locale. On parlera d'un carcinome in situ lorsque la tumeur ne dépasse pas la membrane basale.

On parlera d'un carcinome invasif lorsqu'elle va dépasser la membrane basale. Une fois on aura une extension beaucoup plus importante, on parle d'un carcinome infiltrant. A partir de là, on va avoir une extension locale, mais il faudra comprendre certaines choses pour pouvoir assimiler cette extension locale.

Première chose, d'abord, il n'y a pas de limite entre les trois étages. C'est-à-dire qu'une tumeur au niveau de l'étage glottique peut facilement s'étendre vers l'étage soglottique ou bien vers l'étage soglottique. Là, on ne peut avoir un cancer des trois étages.

Deuxième point, il y a des points de faiblesse au niveau du larynx qui permettent et qui facilitent l'extension. Par exemple, la membrane crico-thyroïdienne qui relie le cartilage cricoïde au cartilage thyroïde peut facilement permettre l'extension à partir d'une tumeur endolaryngée et faciliter l'extension au niveau des parties molles antérieures, c'est-à-dire en avant du larynx. Le ventricule de Morgagni, lui aussi, c'est une zone de faiblesse.

La commissure antérieure, c'est un point de faiblesse très important puisque la commissure antérieure correspond à la zone d'insertion des cordes vocales au niveau du cartilage thyroïde. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de péricorde. Le péricorde est constitué d'une barrière à l'extension tumorale.

Alors, puisque à ce niveau-là, le péricorde est absent, l'extension peut se faire facilement à travers le cartilage. L'épiglotte aussi, c'est un point de faiblesse. Pourquoi ? Parce qu'il présente

des perforations.

Le cartilage présente plusieurs perforations qui servent de passage pour les vaisseaux et, en même temps, peuvent servir de passage pour l'extension tumorale. En contrepartie, il y a des points de résistance. Le cône élastique, qui est un cône étendu depuis les cordes vocales jusqu'au niveau du bord supérieur du cartilage cricoïde, va limiter l'extension à un certain degré vers l'épiglotte.

Le cartilage thyroïde avec son péri-corde ainsi que le cricoïde sont des ondes de résistance. La membrane hyoépiglottique, c'est-à-dire entre l'os imide et l'épiglotte, est une barrière à l'extension tumorale vers la base de l'onde. On comprend, à partir de là, qu'on peut avoir une extension du cancer du larynx en intralarynge, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cancer d'un étage et, au cours de l'évolution, arriver à un cancer qui va toucher les trois étages.

Comment peut-on avoir une extension à travers le larynx? On parle d'extension extralaryngique, c'est-à-dire en avant vers les parties molles syndicales, en arrière vers la bouche de l'œsophage, en haut vers la base de l'onde ou, bien latéralement, vers l'hypopharynx et les sinus péri-formes. En plus de l'extension locale, on peut avoir une extension, ce qu'on appelle une extension latérale régionale, c'est-à-dire des métastases ganglionnaires. On a vu dans le drainage lymphatique qu'il est croisé, donc on peut avoir des métastases bilatérales.

Ça concerne surtout les groupes 2, 3, 4 et le 6, exceptionnellement le 5, mais à retenir que l'étage glottique ne donne pas de métastases ganglionnaires. Les métastases à distance se font surtout au niveau des poumons, parfois au niveau de l'os. Là, c'est un schéma qui montre un petit peu l'extension qui peut se faire à partir d'une tumeur localisée, par exemple dans ce cas-là, une tumeur au niveau de la face laryngée de l'épiglotte peut s'étendre facilement en avant à travers l'épiglotte, on l'a dit que l'épiglotte c'est une zone de faiblesse, peut s'étendre facilement au niveau de la loge pré-épiglottique.

On voit ici en jaune, c'est la graisse pré-épiglottique. Une tumeur du ventre ou de la morganie peut donner facilement une extension vers l'étage susglottique. Une tumeur qui touche la commissure antérieure, comme on l'a vu, c'est une zone de faiblesse où il n'y a pas de périchondres.

Vous voyez ici, on peut avoir une extension facile à travers le cartilage et on peut avoir une empiètement au niveau des parties molles cervicales. Alors, à partir de là, on peut instaurer ce qu'on appelle une classification de l'extension tumorale en des stades, ce qu'on appelle la classification TNM. T, c'est l'extension de la tumeur.

N, c'est l'extension au ganglion. M, c'est l'extension métastatique, c'est-à-dire la métastase à distance. Alors, le T1, c'est une tumeur qui est limitée à un seul étage avec des cordes vocales qui sont mobiles.

T2, c'est une tumeur qui est étendue à l'étage sus ou sous-jacent, mais avec une mobilité des cordes vocales qui est conservée. Dans le T3, la tumeur reste limitée au larynx, mais avec une corde vocale qui est fixée. Donc, remarquez ici que dans cette classification, il n'y a pas que l'extension, il y a aussi la mobilité des cordes vocales, la mobilité aussi des aréthénuïdes.

Une fois les aréthénuïdes qui sont fixés, au moins un aréthénuïde qui est fixé, en bas, on est déjà au stade 3. C'est-à-dire on est dans un T3. Lorsque la tumeur envahit les cartilages thyroïdes, crécuïdes, ou elle est étendue aux structures extralaryngées, on parle d'un T4, c'est-à-dire que la tumeur est avancée localement, c'est-à-dire elle atteint des sinus spiriformes, des cartilages thyroïdes, trachées, oesophores. Alors, concernant l'extension gonglionnaire, dans le N0, il n'y a pas d'adénopathie cervicale palpable.

Dans le N1, c'est une adénopathie présente, une adénopathie unique, une seule, qui est homolatérale à la tumeur et qui est inférieure à 3 cm sans extension extra-gonglionnaire. Alors, comment on reconnaît l'extension extra-gonglionnaire ? C'est à la palpation, lorsque l'adénopathie est fixée, ou bien lorsqu'on remarque qu'il y a une extension au niveau de la peau, ou bien lorsqu'on a une atteinte nerveuse associée, c'est-à-dire que le gonglion est rompu et qui est étendu localement, qui a entraîné une atteinte nerveuse, par exemple une atteinte du spinal, par exemple. Dans le N2, il n'y a pas d'extension extra-gonglionnaire, on parle d'un N2A, lorsque l'adénopathie est entre 3 et 6 cm, qui est homolatérale et unique.

Lorsque les adénopathies sont multiples et homolatérales, mais inférieures à 6 cm, sans extension extra-gonglionnaire, on parle de N2B. Dans le N2C, les adénopathies sont bilatérales, ou bien contralatérales, mais sont inférieures à 6 cm et sans extension extra-gonglionnaire. Dans le N3, il y a le N3A, lorsque l'adénopathie est supérieure à 6 cm et sans extension extra-gonglionnaire.

Et dans le N3B, c'est lorsque l'adénopathie est unique ou multiple, mais avec extension extra-gonglionnaire. Alors, pourquoi on insiste sur l'atteinte gonglionnaire ? Parce que c'est un élément pronostic très important. Un cancer du larynx sans métastase gonglionnaire n'a pas le même pronostic qu'un cancer du larynx avec atteinte gonglionnaire, surtout si on a une extension extra-gonglionnaire.

C'est-à-dire que le pronostic devient mauvais. Alors, concernant les métastases à distance, lorsqu'on appelle les métastases à distance, on parle de N0. Lorsqu'ils sont présents, on parle de N1.

Alors, à partir de là, on va installer des stades, stade 1 jusqu'au stade 4C. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais juste comprendre. Regardez ici, par exemple, dans le stade 3. C'est un T3 avec N0, M0, c'est-à-dire pas de métastase gonglionnaire.

Mais lorsque on a un T3 toujours, ou bien on a un T1 et T2, mais avec des métastases

gonglionnaires de stade N2, ça devient un stade 4. Même si on est devant un T1 ou un T2. C'est-à-dire T1 est une tumeur localisée, par exemple, au niveau de la corde vocale. On ouvre la bande ventriculaire, mais avec des métastases gonglionnaires de stade N2.

C'est un stade 4. Pourquoi on le classe en stade 4 ? Même si c'est une petite tumeur, c'est parce qu'il y a des métastases gonglionnaires qui sont avancées. Et dans ce cas-là, le pronostic n'est pas le même, le stade est assez important. Alors, concernant le diagnostic positif, on va prendre le type de description le plus fréquent.

C'est le cancer glottique. Alors, quels sont les signes d'appel du cancer glottique ? D'abord, il y a la dysphonie chronique. C'est une dysphonie qui va apparaître de façon progressive, mais qui va persister.

Elle ne va pas disparaître malgré tous les traitements qu'on peut instaurer. C'est une dysphonie qui va s'aggraver et qui va durer dans le temps. C'est à partir de là que le médecin généraliste doit s'alarmer, informer le patient qu'il faudra voir un spécialiste pour compléter le bilan et faire une masophiloscope.

Là, c'est un réflexe qu'il faut avoir et qu'il faut garder durant toute votre pratique quotidienne. Une dysphonie chronique qui dure plus de 15 jours faisant patient de plus de 40 ans, surtout s'il est tabagique, impose un examen ORL, impose une masophiloscope. Pourquoi ? Parce que si le patient n'est pas diagnostiqué à temps, on va passer à d'autres symptômes qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus alarmants.

Après la dysphonie, c'est la dysplie, parce que la tumeur va obstruer la lumière laryngée. Le patient va présenter une dysplie inspiratoire avec une bradipnée, avec un tirage, avec un stridor. Après, on va avoir une dysphagie, surtout si c'est la tumeur ou si c'est un susglottique ou bien si on a une extension au niveau de la bouche de l'œsophage.

Le patient peut venir consulter juste pour une adénopathie cervicale. Il ne fait pas attention à sa petite dysphonie qui persiste, mais il y a une adénopathie cervicale qui est en train de grossir. Dans certains cas, on peut avoir des autalgies réflexes, surtout lorsqu'on est devant une localisation susglottique.

Donc, devant tout patient qui a des autalgies, vous faites votre interrogatoire et examen autologique. Il est strictement normal. Il faut penser à une autalgie réflexe et examiner obligatoirement la muqueuse des voies aériennes supérieures.

On peut avoir des crachats hémoptéiques et une sensation de corps étranger. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire après ? Il faut absolument examiner le larynx. Comment on fait ? Il y a deux méthodes.

La classique, c'est l'examen au miroir. C'est ce qu'on appelle la laryngoscopie indirecte. C'est-à-

dire qu'on va faire introduire un miroir à travers la cavité buccale juste derrière la base de langue avec une lumière frontale pour éclairer le larynx.

Alors, on aura une image réfléchie du larynx. Vous voyez le schéma sur la photo ici. On tient la langue entre le pouce et le biome et l'index qui pose la lèvre supérieure tandis que notre main introduit le miroir à larynger pour essayer de retrouver l'image du larynx.

A partir de là, on va demander aux patients de prononcer le son I pour voir s'il y a une mobilité correcte et en même temps explorer la muqueuse laryngée pour voir s'il n'y a pas de tumeur visible. Deuxième technique qu'on utilise actuellement parce que maintenant chez les spécialistes on ne fait plus de laryngoscopie indirecte on fait ce qu'on appelle une nasophibroscope C'est une fibroscopie qu'on fait à travers les fosses nasales pour passer derrière le voile du palais et entendre directement sur le larynx qu'on peut explorer de façon claire on peut enregistrer les images pour les revoir tranquillement après on ne passe pas à travers le larynx parce que ça va déclencher un réflexe nos yeux qui est gênant qui peut parfois perturber l'examen chose qui arrive souvent lorsqu'on arrive lorsqu'on fait une laryngoscopie indirecte donc cette nasophibroscope va nous permettre de voir la muqueuse laryngée explorer les piglottes, les apteries l'étage subsquelotique, l'étage glotique parfois on peut avoir même l'étage en partie l'étage subglotique donc on aura un examen morphologique du larynx en même temps on fait un examen dynamique pour voir est-ce que la mobilité des cordes recong et des arétonuïdes est perturbée, quand on parlera d'une mobilité qui est correcte, qui est normale ou bien d'une mobilité qui est diminuée ou bien carrément d'une fixation d'un arétonuïde ou bien des deux arétonuïdes lorsqu'on parle de fixation d'un arétonuïde c'est-à-dire la fixation de l'arétonuïde et de la corde recong la nasophibroscope permet de visualiser la morphologie c'est-à-dire voir est-ce qu'il y a une tumeur au niveau du larynx, en même temps d'explorer la dynamique laryngée, la mobilité des cordes recong. Après on fera un examen cervical, d'abord pour palper le larynx, palper l'écartilage laryngée, voir est-ce qu'il y a des modules de permeation, c'est-à-dire une extension de la tumeur à laryngée au niveau des parties molles antérieures après on fera une palpation des aires ganglionnaires le long de la chaîne jugulaire auxiliaire, on palpera le groupe 2, 3, 4 5, on terminera par l'examen du groupe 1 après il faudra mettre un schéma sur lequel on va faire le schéma du larynx pour montrer le siège de la tumeur, marquer est-ce que leur larynx est mobile ou non, et mettre un schéma de la région cervicale pour noter est-ce qu'il y a des adénopathies homolatérales, bilatérales, contralatérales leur nombre et leur taille et si on suspecte une extension extraganglionnaire ou non, alors une fois on a terminé l'examen du larynx il faudra compléter par l'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx pour voir est-ce qu'il y a une deuxième lésion qui est associée pour bien vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'ulcérations au niveau de la langue, l'ongle buccale les amygdales, le reste de la muqueuse oropharyngée, la base de langue et en même temps vérifier l'état dentaire du patient pour noter est-ce qu'il y a au nom des caries dentaires qu'il faudra traiter pour préparer le patient éventuellement à une radiothérapie on terminera par un examen général c'est-à-dire un examen cardiovasculaire un examen pleuropulmonaire un examen ostéoarticulaire pour rechercher est-ce qu'il y a des signes d'appel

de métastase à distance deux, pour évaluer l'état général du patient pour voir est-ce qu'il y a des comorbidités qui sont associées et qui peuvent influencer les indications thérapeutiques donc là c'est des photos de certains types de tumeurs alors par exemple sur la photo A ici à droite on voit très bien à la masophiroscopie les deux cordes vocales la corde vocale droite, la corde vocale gauche la promessure antérieure celui-là c'est le ventricule de Morgagnie et là c'est les bandes ventriculaires entre les deux cordes vocales on voit la sous-glotte et remarquez ici l'aspect tumoral de la corde vocale droite même chose ici on voit la corde vocale gauche qui est saine la promessure antérieure qui est saine mais là on a un épaississement irrégulier de la corde vocale droite avec des lésions de leucoplasie c'est des lésions blanchâtres mais on voit qu'il y a un épaississement on dirait qu'il y a une infiltration en profondeur de la corde vocale droite ça c'est une photo qui montre une tumeur bourgeonnante de la corde vocale droite qui arrive au contact de la promessure antérieure et qui s'étend vers l'aryténoïdienne en arrière même chose ici, on voit qu'on a une tumeur qui est centrée sur la promessure antérieure c'est une tumeur qui est bourgeonnante qui est saignante elle est très suspecte de malignité avec les deux tiers postérieurs des deux cordes vocales qui sont saines donc ça c'est la corde vocale droite la corde vocale gauche, la tumeur sur la promessure antérieure les deux bandes ventriculaires avec le reste de l'étage susglottique ça c'est les images qu'on peut avoir à la masochiloscopie et qui sont de très bonne qualité et qu'on peut enregistrer, revoir tranquillement ou voir au moment des contrôles en même temps, on n'oubliera pas au moment de la masochiloscopie de vérifier la mobilité des cordes vocales et des arrêtees alors une fois qu'on a fait la masochiloscopie et qu'on a retrouvé la tumeur et qu'on a fait le reste de l'examen clinique il faudra faire le complément de bilan pour essayer de vérifier l'extension de cette tumeur et d'essayer de confirmer le caractère malin de cette tumeur théoriquement il faut aller explorer et faire une biopsie en premier mais ce qu'on fait en général c'est qu'on commence par un scanner cervical on commence par un scanner cervical en premier parce que la biopsie va entraîner des phénomènes inflammatoires de l'œdème qui peut donner de faux résultats au scanner donc l'examen cervical va explorer la sous-glotte puisqu'il est difficilement explorable à la masochiloscopie il va explorer l'écartilage thyroïde cricoïde, la loge pré-épiglottique ainsi que l'espace paraglottique et rechercher la présence de la démopathie cervicale et vérifier est-ce qu'il y a une extension au niveau par exemple de la base de langue, une extension au niveau des paravertébraux antérieurs ou même une extension latéralement vers la région jugulaire ou bien vers l'œsophage ou bien le dysphagisme cervical après on fera une laryngoscopie directe comme vous la voyez ici sur la photo à droite c'est un examen qui est fait sous anesthésie générale on place un laryngoscope et on peut compléter par un microscope pour agrandir l'image et pouvoir bien explorer alors qu'est-ce qu'elle permet de faire elle permet de réexplorer les trois étages du larynx situer exactement le siège de la tumeur palper la tumeur pour mieux apprécier l'extension faire des biopsies qui vont être orientées sur la tumeur sur les berges de la tumeur, sur les zones saines pour cartographier le siège de la tumeur et comme ça on pourra évaluer le type de la tumeur sa localisation et son extension locale et le tout se fait bien sûr sous anesthésie générale alors ces biopsies vont être acheminées au laboratoire d'un intendant pathologie où ils vont être étudiés pour confirmer le

diagnostic alors une fois le diagnostic confirmé on va compléter par une panendoscopie panendoscopie, c'est à dire un ensemble d'examen endoscopiques on va examiner les oesophages l'épopharynx, plus ou moins une bronchoscopie pour rechercher une tumeur synchrone, une tumeur maligne synchrone, pourquoi ? les différents sites qu'on vient de citer présentent en commun le tabagisme comme facteur de risque d'apparition de cancer, donc puisque on a déjà un cancer au niveau de l'arax on peut l'avoir au niveau des poumons, on peut l'avoir au niveau des oesophages au niveau des bronches, au niveau de l'épopharynx au niveau de l'orparax ou bien de rhinoparax donc il faudra obligatoirement faire cette panendoscopie pour rechercher une tumeur synchrone à la palpation, à l'endoscopie et faire des biopsies au moindre risque comme ça on pourra diagnostiquer à temps de façon fréquente l'association à un autre tumeur donc là c'est des images scanographiques, par exemple ici on voit une tumeur qui est centrée sur la région cricoïdienne sur la commissure antérieure cette localisation sur la commissure antérieure comme on l'a dit, c'est une zone de faiblesse puisqu'on voit que la tumeur, elle a facilement franchi le cartilage thyroïde avec une extension au niveau des parties antérieures là c'est une tumeur de la corde vocale droite avec extension au niveau de l'espace paraglottique là on remarque que le cartilage thyroïde reste intact, donc on a une tumeur sur la corde vocale droite qui s'étend à la commissure antérieure là, sur le contraire, c'est une tumeur au dépend de la corde vocale droite avec un cartilage qui est intact et des arrêts thyroïdes qui sont intacts là on a une tumeur qui ressemble au premier cas avec une tumeur centrée sur la commissure antérieure que l'on remarque sur la loge HTE qui franchit le cartilage thyroïde avec une atteinte de muscles sous-zérydiens alors une fois le cancer, il est confirmé il faudra faire un bilan d'extension ce bilan d'extension est basé d'abord sur la clinique comme on l'a dit lors de l'examen général il faut compléter par un scanner thoracique et une infographie abdominale tout en sachant que le cancer du larynx donne rarement de métastases au niveau abdominale et surtout au niveau thoracique, parfois au niveau de l'os donc on fait un scanner thoracique et en fonction des signes d'apaisement si on a des douleurs osseuses par exemple il faudra compléter par une imagerie telle des radiographies standard ou des scanners pour mieux rechercher ces métastases après on va réaliser un bilan très thérapeutique pour évaluer l'état psychosocial du patient c'est à dire avoir une vue sur sa profession puisque le cancer touche un organe de la communication c'est un organe qui participe à la phonation, à la déglutition à la respiration donc il faut avoir une idée sur la profession du patient sur son état psychosocial évaluer l'état nutritionnel détecter une dénutrition et essayer de la corriger pour le préparer au traitement si il y a une indication à une chirurgie partielle il faudra faire une exploration fonctionnelle respiratoire en cas d'anomalie révélée par cette exploration fonctionnelle respiratoire ça dans ce cas là c'est une contre indication à la chirurgie partielle du larynx il faudra évaluer l'état cardiovasculaire rénale, hépatique et évaluer l'état dentaire en réalisant l'examen stomatologique avec un orthopantomogramme traiter les caries dentaires pour préparer le patient à une éventuelle radiothérapie alors quelles sont les formes topographiques on a vu comme type de description de cancer biologique premier type topographique d'abord c'est le cancer cisglottique alors il va se manifester beaucoup plus par une dysphagie une sensation

d'accrochage alimentaire une odéonophagie et surtout des autalgies réflexes dans ce cas là dans ce genre de tumor cislottique on a une destruction du cartilage épiglottique qui est une zone de faiblesse avec envahissement de la loge pré-épiglottique le cancer cislottique est très lymphophile il est plus lymphophile que le cancer ceglottique-épiglottique dans ce cas là on aura beaucoup plus de métastases l'ouvrier nerf qui faudra le cancer de la subplotte il est souvent latent il ne va pas se manifester obligatoirement par une dysphonie assez importante mais il va se manifester sur tout un display larangé qui va s'installer progressivement l'extension se fait dans ce cas là vers l'étage glottique et surtout vers la trachée il faut retenir que dans ce cas là dans cette forme on a des métastases l'ouvrier nerf au gros 6 c'est à dire pré-larangé, pré-trachéale et au niveau de la chaîne inférentielle qu'il faudra traiter si on propose un traitement chirurgical le cancer est de 3 étages c'est à dire que la tumeur a le temps d'évoluer à traverser les 3 étages du larynx et c'est souvent le point de départ au niveau ventriculaire d'autres formes cliniques c'est les formes localement avancées c'est à dire les T3 et les T4 dont les formes à des fixités de cordes vocales c'est à dire que la tumeur a évolué a bloqué les muscles intrinsèques du larynx elle a touché l'articulation tricho-arytenuide et un arytenuide ou bien les deux ne peuvent plus bouger on est déjà au stade T3 l'extension antérieure vers la glande thyroïde les muscles sous-iliidiens en l'occurrence en cas de carcinogène de la commissure antérieure et l'extension latérale vers le sinus pyriforme dans ce cas là on aura une sensation d'accrochage alimentaire ou dysphagie l'extension basse dans certains cas vers la trachée, l'osophage dans ce cas là on aura une dysphagie ou bien l'extension haute c'est à dire au niveau de la base de langue pour rappel, l'exploration de la base de langue se fait à l'homogénéie mais se fait aussi au moment de la marroscopie directe en palpant avec l'index toute la base de langue la palpation de la base de langue au moment de la marroscopie directe est un point très important qui permet de vérifier s'il y a une extension soumiqueuse qu'on n'arrive pas à voir à l'oeil nu et qu'on peut découvrir rien qu'à la palpation de la base de langue chez un patient qui est sous anesthésie générale les formes métastatiques c'est à dire soit avec les métastases ganglionnaires c'est un élément pronostic très important ou bien les métastases à distance au niveau des poumons, de l'os ou autre alors avant de parler du traitement il faudra d'abord éliminer les diagnostics en premier les laryngites chroniques c'est vrai qu'elles constituent des états précancéreux c'est à dire qu'elles peuvent évoluer vers un cancer du larynx et de ce fait elles nécessitent un suivi au long cours tout patient qui a une laryngite chronique nécessite des contrôles réguliers surtout endoscopiques avec de temps en temps des prélèvements des biopsies et des examens anatomopathologiques pour vérifier s'il y a passage ou non vers la dégénérescence maligne la tuberculose laryngée la tuberculose laryngée c'est une infection omicobactériaie en tuberculosis et qui peut se manifester dans certains cas sous une forme bourgeonnante pseudo-tumorant dans ce cas là ça peut donner un aspect trompeur mais on peut suspecter la tuberculose devant un larynx sale lorsqu'on a une tumeur comme on a vu sur la photo précédente le larynx n'est pas infecté vous avez la tumeur bourgeonnante mais le reste de la muqueuse est propre lorsqu'on a une tuberculose on a l'impression que le larynx est sale et qu'il y a des sécrétions poudélanges partout dans ce cas là il faudra suspecter et orienter l'anatome pathologiste pour rechercher des

signes en faveur de la tuberculose laryngée la papillomatose laryngée donne des touffes des lésions sous forme de papilles au niveau de la muqueuse et en général l'anatome pathologique permet facilement de poser le diagnostic d'autres tumeurs bénignes par exemple les laryngocelles les chondromes ou autres ça en général c'est l'anatome pathologique qui permet de poser le diagnostic alors concernant le traitement quels sont les objectifs pour traiter un cancer de larynx d'abord c'est l'éradication complète de la tumeur et des métastases deuxième objectif c'est la préservation des trois fonctions du larynx quand c'est encore possible parce que dans certaines formes il est impossible de conserver les trois fonctions du larynx surtout dans les formes évoluées alors quels sont les moyens dont on dispose il y a la chirurgie, la radiothérapie surtout les deux en plus de la chimiothérapie dans la chirurgie on reconnaît deux techniques la laryngectomie partielle et la laryngectomie totale la laryngectomie partielle consiste en quoi c'est à enlever une partie du larynx et reconstruire le larynx sur les structures qui restent pour conserver les trois fonctions du larynx c'est à dire que le patient qui a bénéficié d'une laryngectomie partielle va pouvoir parler, respirer par son larynx et va pouvoir déglutir et s'alimenter de façon normale le principe c'est la conservation du cricoïde et des aréthénoïdes la conservation de ces deux structures nous aide à conserver ces trois fonctions du larynx alors cette chirurgie peut se faire par voie endoscopique actuellement elle est faite de plus en plus par voie endoscopique au laser ou bien elle peut se faire par voie externe on parle de laryngectomie verticale par exemple dans les cordectomies lorsqu'on a un tumeur qui est localisé uniquement à la corde vocale donc on peut la faire soit par voie endoscopique au laser lorsque l'exposition est correcte et qu'on arrive à bien s'exposer on peut faire la cordectomie au laser ou bien on peut la faire par une incision externe aller ouvrir le larynx, faire l'exérèse tumorale et fermer et reconstruire on parle de laryngectomie horizontale c'est à dire soit supraglottique par exemple si on a besoin de conserver un étage supraglottique on peut faire une laryngectomie en emportant l'étage subglottique et conserver l'étage glottique et subglottique et amarrer la base de langue au reste du larynx ou bien on parle de laryngectomie supracrétouillienne c'est à dire que la tumeur est localisée par exemple au niveau de l'étage glottique ou bien glottosubglottique dans ce cas-là on emporte les cordes vocales on laisse les deux avec le crétouille et on amarre la base de langue avec l'océoïde, plus ou moins l'upiglotte au crétouille dans ce cas-là on a besoin de trachyotomie mais qui est provisoire et pas définitive comme on l'a dit dans la laryngectomie partielle le principe c'est de conserver les trois fonctions du larynx entre autre la respiration le patient à la fin doit pouvoir respirer de façon normale à travers son larynx la trachyotomie dans ce cas-là est provisoire alors ces laryngectomies partielles ont des contre-indications qui sont d'abord la fixation des aryénoïdes lorsqu'on a un aryénoïde ou des aryénoïdes qui sont fixés par la tumeur il est inconcevable de faire une laryngectomie partielle puisqu'on ne pourra pas conserver le crétouille dans ce cas-là on ne pourra pas conserver les aryénoïdes l'extension soglotique c'est la même chose l'extension massive à l'espace pré-épiglottique ne nous permet pas de faire une laryngectomie partielle avec des marges d'exérès sur SM c'est une contre-indication à la chirurgie partielle et bien sûr lorsqu'on est devant un patient qui a un mauvais état respiratoire dans ce cas-là on ne pourra pas faire de chirurgie partielle parce que dans les suites

post-opératoires précoces d'une laryngectomie partielle il y a des fausses routes le patient fait des fausses routes de façon transitoire il a besoin d'un temps pour pouvoir réapprendre à s'alimenter de façon progressive alors cet apprentissage demande du temps et en attendant le patient fait des fausses routes alors qu'il y a des fausses routes, des infections respiratoires si on est sur un poumon qui est déjà malade on peut tomber dans des complications respiratoires sévères voire mortelles et de ce fait un mauvais état respiratoire est une contre-indication à la laryngectomie partielle alors là c'est un schéma qui montre certains types de laryngectomies partielles par voie externe, par exemple ici vous avez la cordectomie c'est une tumeur de la corde vocale droite, on ouvre le larynx en avant on rentre, on enlève la corde vocale et puis on ferme, c'est la chirurgie la plus simple là c'est une chirurgie partielle frontolatérale lorsque la tumeur touche la corde vocale et s'étend vers la commissure antérieure, on enlève la corde vocale ainsi que l'angle antérieur du cartilage on va reconstruire enfin ça c'est une laryngectomie supraglothique la tumeur est localisée à l'étage supraglothique, on fait ce qu'on appelle une laryngectomie supraglothique et après on va amarrer la base de langue avec le cartilage thyroïde et là c'est un type de laryngectomie supracrécôidienne puisque la tumeur touche l'étage glothique et dans ce cas là on va amarrer l'ocyoïde ce qui reste de l'épiglotte avec le cartilage crécôïde.

Dans ces chirurgies là la laryngectomie est transitoire et le patient s'alimente de façon normale et respire de façon normale à travers son larynx alors toujours dans les moyens thérapeutiques dans la chirurgie, on a parlé de laryngectomie partielle, il y a la laryngectomie totale c'est à dire l'ablation totale du larynx. Lorsqu'on enlève le larynx on va fermer le pharynx et on réalisera en même temps un trachéostome, dans ce cas là il n'est pas provisoire il est définitif avec une perte de la voix naturelle. Cette laryngectomie totale peut s'étendre à la base du larynx à l'épiglotte pharynx, à la trachée ou parfois au niveau du partitionnement syndical et de ce fait elle nécessitera une réhabilitation vocale qui va être aidée par une réhabilitation orthophonique cette réhabilitation vocale peut se faire par la mise en place d'une prothèse phonatoire on va le voir après ou bien apprendre aux patients la voix oesophagienne grâce à une rééducation orthophonique ou bien l'aider à parler avec un électrolarynx, ce qu'on appelle un laryngophone Alors là c'est un schéma qui montre un petit peu la technique de laryngectomie partielle là ici le larynx a été complètement enlevé et on va fermer la muqueuse pharyngeale là il est fermé là vous voyez le larynx au cours de la chirurgie on a enlevé le larynx ça c'est le pharynx qui est ouvert et on va situer la muqueuse les deux bouts de la muqueuse pharyngeale pour créer ce qu'on appelle un néopharynx à la fin le patient aura une trachéotomie définitive alors trachéotomie définitive, c'est à dire que le patient va respirer par sa trachéotomie il va s'alimenter de façon normale à travers son néopharynx mais pour pouvoir parler soit il va apprendre la voix oesophagienne soit il faudra lui mettre une prothèse phonatoire c'est quoi une prothèse phonatoire ? c'est une communication qu'on va créer entre la trachée et l'oesophage cette communication va être calibrée et maintenue par une prothèse qui va assurer le passage de l'air à partir de la trachée vers l'oesophage et va remonter pour passer par des cavités de résonance et être articulée par la cavité vocale, les lèvres et la langue et comme ça le patient va avoir une voix de bonne qualité mais bien sûr tout ça aidé par une rééducation orthophonique Alors toujours dans la chirurgie comme on l'a dit il y a la

laryngectomie partielle ou bien la laryngectomie totale ça c'est pour la tumeur pour émettre le passage ganglionnaire il faut faire ce qu'on appelle un curage ganglionnaire cervical c'est à dire une cellulolymphadélectomie pour enlever tout le tissu celluloganglionnaire au niveau des aires ganglionnaires ce curage ganglionnaire il est bilatéral et il est systématique même s'il n'y a pas d'adenopathie qui sent palpable il va concerner le groupe 2, 3 et 4 plus ou moins le groupe 6 si on a une localisation sogmatique alors ce curage ganglionnaire il est systématique sauf lorsqu'on est devant une tumeur limitée aux cordes vocales comme on l'a dit à ce niveau là il n'y a pas de drainage lymphatique et on n'est pas obligé de faire le curage ganglionnaire dans ce cas là, il n'est pas indiqué toujours dans les moyens thérapeutiques après la chirurgie il y a la radiothérapie la radiothérapie sur la tumeur où il faudra donner une dose entre 65 et 70° il faudra faire une radiothérapie sur les ganglions lorsque il n'y a pas d'adenopathie la dose est de 50° mais lorsqu'on est devant une adenopathie lymphatique on passe à 65° cette radiothérapie peut être exclusive c'est à dire qu'elle n'est pas associée ni à la radiothérapie, ni à la chimiothérapie comme elle peut être réalisée en post-opératoire associée ou non à la chimiothérapie cette radiothérapie a des complications d'abord la mucite la lésion très importante de la muqueuse des voies aériennes supérieures qui va être responsable d'une dysphagie d'un oedème laryngé d'une xerostomie qui est responsable d'une sécheresse buccale fibroses, parfois même des sténoses une radionécrose de l'os mandibulaire lorsqu'une irradiation remonte trop en haut et elle est responsable surtout d'une hypothyroïdie qui est très fréquente chez les patients qui ont eu une irradiation cervicale la chimiothérapie à base de 5 fluor 6 platines ainsi que le taxin elle peut être utilisée en néoadjuvant adjuvante ou bien concomitante parfois elle est associée à des thérapies ciblées par exemple le CT-XUMAB mais il faut retenir que les deux moyens les deux moyens les plus importants dans ce genre de cancer c'est surtout la chirurgie et la radiothérapie alors toujours dans les moyens thérapeutiques il y a un protocole qu'on utilise qu'on appelle le protocole de préservation laryngée ou bien la stratégie de préservation laryngée c'est à dire dans les cas où normalement il faut proposer une chirurgie mutilante c'est à dire une laryngectomie totale on peut instaurer un protocole de préservation qui peut nous permettre de préserver le larynx et en même temps la fonction laryngée alors on parle de deux protocoles le premier c'est l'europpéen qui est utilisé au Maroc c'est à dire qu'on va faire une chimiothérapie néoadjuvante en premier trois séances de chimiothérapie et évaluer la réponse si on a une diminution du volume tumorale à l'examen endoscopique et au scanner et cette diminution dépasse 50% on parle d'un bon répondeur et dans ce cas là on va suivre par la radiothérapie c'est à dire qu'on va faire une radiothérapie après la chimiothérapie si le patient est mauvais répondeur c'est à dire qu'à l'examen endoscopique et au scanner la diminution du volume tumorale ne dépasse pas 50% dans ce cas là il faut passer à la chirurgie c'est à dire une laryngectomie totale avec un curage ganglionnaire, syndical, bilatéral le deuxième type de protocole c'est celui qui est utilisé chez les anglo-saxons surtout aux Etats-Unis c'est la chimiothérapie et la radiothérapie concomitantes d'emblée et si il y a un échec on passe à la laryngectomie totale en fait c'est pas un protocole de préservation laryngique puisqu'on part directement vers un traitement une chimiothérapie d'emblée alors quelles sont les indications de ce protocole de conservation laryngique c'est les

tumeurs T3 puisqu'il n'y a pas d'indication à la chirurgie partielle qui concerne une partie du larynx donc on indique ce protocole dans les tumeurs classées T3 alors les contre-indications de cette stratégie de préservation laryngique c'est d'abord lorsqu'on a une contre-indication à la chimiothérapie et deux lorsqu'on a une lésion cartilagineuse franche parce que les patients qui ont une lésion cartilagineuse franche ce sont de mauvais répondeurs à la radiothérapie en général ce genre de tumeurs sont radioresistants alors quelles sont les indications thérapeutiques en matière de conservation de larynx pour pouvoir résumer d'abord les indications se font au cours d'une réunion qui va englober le médecin le médecin en ORM le médecin radiothérapeute en COLOG le radiothérapeute pathologiste ainsi que le radiologue le dossier du patient va être présenté on va pouvoir discuter des différents aspects du patient sa profession, le stade de la tumeur le genre d'extension, les pathologies associées les comorbidités à temps de respiratoire cardiaque, rénal, etc.

et à partir de là on peut sortir avec une indication thérapeutique, c'est ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire alors pour les tumeurs glottiques osseuses glottique T1 soit une radiothérapie exclusive soit une laryngectomie soit une laryngectomie partielle plus ou moins un curage ganglionnaire sauf si on a une atteinte glottique pure donc là, les deux attitudes se valent c'est à dire, ils ont les mêmes chances de guérison dans le T1 glottique, osseux glottique soit une radiothérapie exclusive, soit une laryngectomie plus ou moins un curage ganglionnaire dans les tumeurs glottiques osseuses glottique T2 là, la laryngectomie partielle plus que le curage ganglionnaire donne plus de bons résultats que la radiothérapie donc la première option c'est la chirurgie partielle avec un curage ganglionnaire sinon c'est la radiothérapie s'il y a une contre-indication à la chirurgie mais si le patient refuse la chirurgie dans les T3, comme on l'a dit tout à l'heure c'est à dire que le larynx est fixé dans la tumeur glottique osseuse glottique, dans ce cas là, on propose soit une stratégie de préservation laryngée si le patient est bon répondeur on continue avec la radiothérapie si il est mauvais répondeur, il faut passer à la laryngectomie totale plus que le curage ganglionnaire bilatéral ou bien partir dans certains cas d'emblée vers une chirurgie totale lorsqu'on est devant un T3 en cas d'atteinte ou en cas d'atteinte osseuse glottique lorsqu'on est devant un T4 ou on est devant un cancer osseux glottique dans ce cas là, il n'y a pas d'indication à une chirurgie partielle il n'y a pas d'indication à une stratégie de préservation laryngée le meilleur traitement c'est la laryngectomie totale ou son curage ganglionnaire bilatéral suivi d'une radiothérapie ou d'une chimiothérapie si l'état général du patient ne le permet pas bien sûr le patient refuse la chirurgie en proposant ce cas là une radiothérapie dans les tumeurs de localisation osseuse glottique lorsqu'on est devant un T1, T2 la meilleure option c'est sur la radiothérapie plus ou moins chimiothérapie pour retenir que lorsqu'on a une atteinte osseuse glottique il n'y a pas d'indication à la chirurgie partielle parce qu'on ne peut pas conserver le cartilage cricoïde dans ce cas là donc on partira vers une radiothérapie sinon c'est une laryngectomie totale avec un curage ganglionnaire bilatéral qui va emporter dans ce cas là aussi le groupe 6 lorsqu'on est devant un T3 ou bien un T4 la meilleure option c'est une laryngectomie totale avec un curage ganglionnaire suivi par une radiothérapie ou bien une radiothérapie bombée alors une fois le patient a été traité soit par chirurgie soit par chirurgie

radiothérapie ou bien radiothérapie exclusive, il faudra assurer une surveillance à vie alors le patient on va le voir chaque 3 mois pendant les 2-3 premières années après on le reverra une fois par an et on va le surveiller par la clinique par le patient cervical la nasofibroscopie par le scanner cervical et par l'endoscopie sous anesthésie générale il faudra instaurer la rééducation orthophonique pour essayer de créer une réhabilitation vocale soit après mise en place d'une prothèse phonatoire ou bien en apprenant au patient la voix oesophagienne ou bien à l'aide d'un électrolarynx il faudra assurer obligatoirement un soutien psychologique puisque c'est des patients qui ont une chirurgie mutilante et qui ont perdu leur organe de communication il faudra les aider psychologiquement puisque la plupart passent par une phase de dépression très importante et les aider dans le sevrage tabagique et bien sûr assurer une réinsertion socio-professionnelle alors qu'en est-il de l'évolution il faut savoir que lorsque le diagnostic est fait de façon précoce ainsi que le traitement la survie à 5 ans est très bonne et remarquez ici pour le T1 glottique la survie à 5 ans dépasse les 90% dont le T2 est entre 50 à 60% pour la susglotte les résultats sont moins bons mais qui restent quand même acceptables avec une survie entre 50 à 70% pour le T1 et T2 par contre pour le T3 et T4 la survie pour les localisations glottiques est entre 30 à 58% mais malheureusement pour les susglottes c'est entre 25 et 50% en général le décès survient soit après un échec local par exemple dans les formes très évoluées il y a des patients qui sont mal surveillés soit par des métastases à distance qui sont avancées localement ou bien par les cancers métachromes c'est-à-dire des cancers qui apparaissent au cours de l'évolution qui sont du siège différent soit au niveau de la trachée, bronche, poumon, oropharynx d'où l'intérêt de la surveillance à long terme on insistera sur la prévention par la lutte contre le tabac et l'alcool à travers les médias au niveau des écoles et à travers les réseaux sociaux traiter et bien sûr surveiller les états précancéreux et guetter toute transformation maligne pour pouvoir traiter les patients alors comme conclusion le cancer de l'arynx c'est un cancer qui est quand même fréquent puisqu'il constitue 25% du cancer de l'appareil respiratoire le tabac est le principal facteur de risque sur lequel on peut jouer grâce à une prévention et une sensibilisation active de la population et éviter le tabagisme qu'on peut voir à des âges encore plus hautes essayez de dépister le cancer de l'arynx à un stade précoce devant toute dysphonie chronique en envoyant le patient chez un spécialiste pour faire une nasopharyngoscopie malheureusement au Maroc le diagnostic reste encore tardif on voit encore des T3 et des T4 de façon beaucoup plus fréquente que les T1 et les T2 la prise en charge est multidisciplinaire le pronostic reste quand même meilleur parmi les cancers des voies aériennes supérieures surtout pour les formes de diagnostics précoces et on insistera aussi sur la nécessité d'une réhabilitation et une réinsertion des patients laryngectomisés